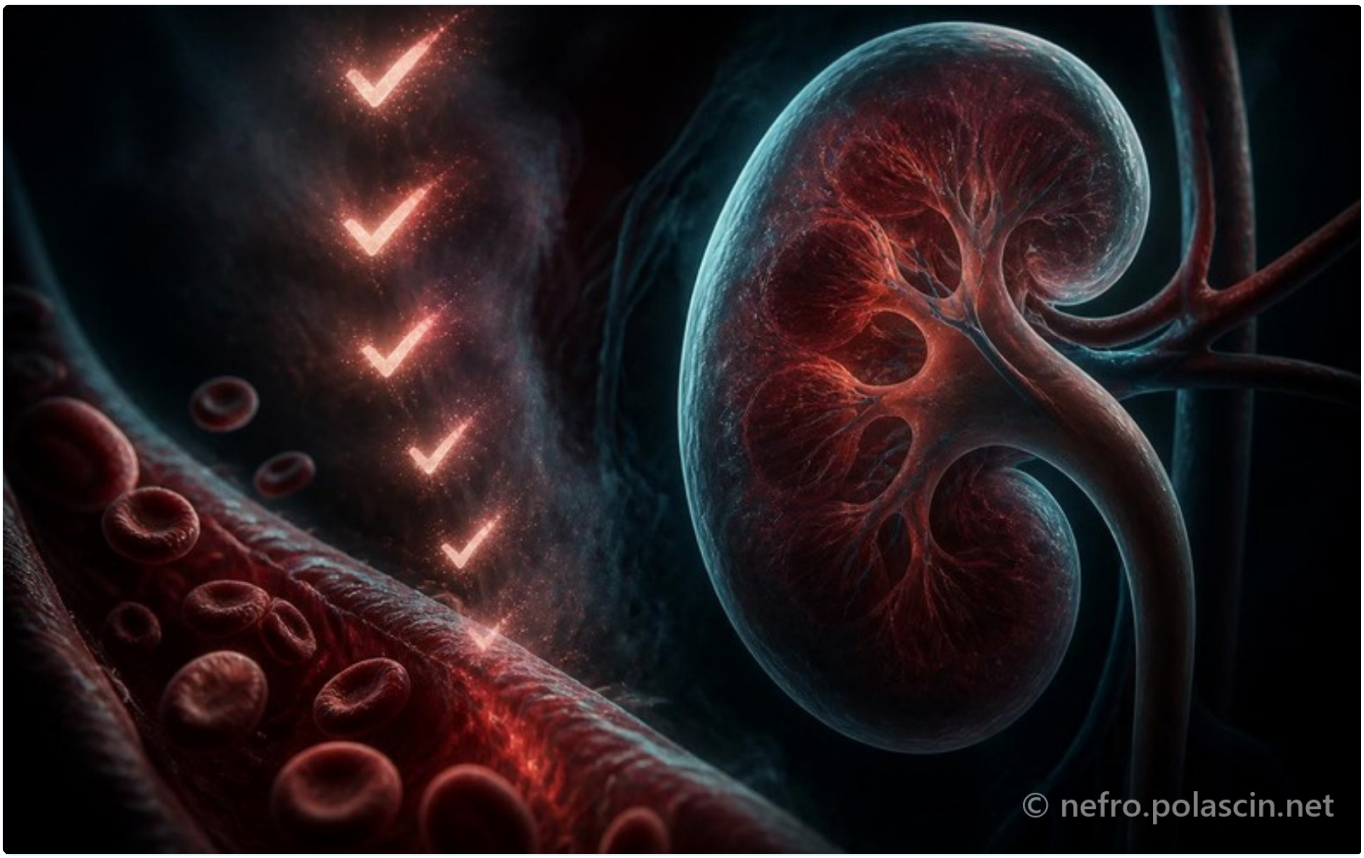
Checklist do praxe: Anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Anémia pri CKD sa rieši postupnosťou krokov, ktorú má zmysel mať po ruke – na dialýze aj v ambulancii.

Článok obsahuje dva praktické checklisty na rýchle použitie v ambulancii a na dialýze. V oboch prostrediach je cieľ rovnaký: potvrdiť anémiu, zhodnotiť železo, rozlíšiť korigovateľné príčiny a potom bezpečne rozhodnúť o liečbe.

Checklist do praxe A4: Anémia pri CKD pre dialýzu (HD/PD)

Záznam pacienta: [PACIENT] | **Dátum:** [DD.MM.RRRR] | **Skupina:** CKD G5D | **Dialýza:** HD/PD

Lekár: [MENO/IDENT] | **Cieľ:** začatie / úprava / monitoring

1) Potvrdenie a rýchle zhodnotenie

- ☐ **Hb** a trend (dátumy): _____
- ☐ **CBC** (MCV, RDW) + **retikulocyty**: _____
- ☐ Symptómy a tolerancia záťaže: _____
- ☐ Zápal, infekcia, krvácanie, nutričný pokles: áno/nie + poznámka _____
- ☐ Ak výsledky nezodpovedajú anémii pri CKD, plán doplnenia diagnostiky: _____

2) Železo ako priorita

- ☐ **Ferritín (ng/ml):** _____
- ☐ **TSAT (%):** _____
- ☐ Kontext zápalu alebo iných faktorov ovplyvňujúcich indexy: _____

3) Rozhodnutie o IV železe

- ☐ Pri **ferritín ≤ 500** a **TSAT ≤ 30** zvážiť / indikovať IV železo: áno/nie
- ☐ Bezpečnostná hranica: **ferritín > 700** alebo **TSAT ≥ 40** → rutinné železo zadržať / neeskalovať: áno/nie
- ☐ Typ IV železa a dávkovací plán: _____
- ☐ Plán kontrolných laboratórií: _____

4) FCM a fosfát

- ☐ Použitý prípravok: FCM / iné: _____
- ☐ Ak FCM, plán kontroly **fosfátu** podľa lokálneho protokolu a kliniky: áno/nie
- ☐ Príznaky po podaní: slabosť, bolesti kostí, iné _____
- ☐ Ak sa objavia, okamžitá kontrola fosfátu a úprava plánu: áno/nie

5) ESA alebo HIF-PHI

- ☐ Korektibilné príčiny vyriešené, najmä deficit železa: áno/nie
- ☐ Zdieľané rozhodovanie s pacientom: áno/nie
- ☐ Pri CKD G5D zvážiť ESA typicky pri **Hb približne ≤ 9,0 až 10,0 g/dl**: áno/nie
- ☐ Pri udržiavaní držať Hb **pod hornou hranicou ~11,5 g/dl**: _____
- ☐ Voľba: ESA / HIF-PHI / zatiaľ nie + dôvod: _____

6) Monitoring

- ☐ Kontrola **Hb, ferritín, TSAT**
- ☐ Interval: **1 až 3 mesiace** (G5HD) alebo podľa lokálneho dialyzačného protokolu (G5PD)
- ☐ Prehodnotenie pri zmene klinického stavu: infekcia, hospitalizácia, krvácanie, rýchly pokles Hb: áno/nie
- ☐ Návrh ďalšej kontroly: [DD.MM.RRRR]

7) Dokumentácia pre audit

- ☐ Dôvod, prečo železo áno/nie, vrátane prahov: _____
- ☐ Dôvod, prečo ESA/HIF-PHI áno/nie: _____
- ☐ Ak FCM, ako riešiš fosfát: _____

Checklist do praxe A4: Anémia pri CKD pre ambulanciu (non-HD)

Záznam pacienta: [PACIENT] | **Dátum:** [DD.MM.RRRR] | **Skupina:** CKD G__ (bez HD)

Lekár: [MENO/IDENT] | **Cieľ:** začatie / úprava / monitoring

1) Potvrdenie anémie a zhodnotenie rizík

- ☐ **Hb** a trend (dátumy): _____
- ☐ **CBC** (MCV, RDW) + **retikulocyty**: _____
- ☐ Symptómy: únava, dyspnoe, intolerancia záťaže a funkčný dopad: _____
- ☐ Klinicky: infekcia/zápal, krvácanie, nutričné zhoršenie: áno/nie + poznámka _____
- ☐ Ak výsledky nezodpovedajú anémii pri CKD, plán doplnenia diagnostiky: _____

2) Železo: panel a interpretácia

- ☐ **Ferritín (ng/ml):** _____
- ☐ **TSAT (%):** _____
- ☐ Kontext zápalu: _____

3) Rozhodnutie o železe

- ☐ Preferovaný spôsob: perorálne / IV: _____

- ☐ Odôvodnenie: tolerancia, rýchlosť korekcie, dostupnosť/cena, laboratórny obraz: _____
- ☐ Pri iniciácii IV železa zohľadniť benefity a riziká: _____

4) FCM a hypofosfatémia

- ☐ Použitý prípravok (ak IV): FCM / iné: _____
- ☐ Ak IV zahŕňa FCM, plán kontrol **fosfátu** podľa rizika pacienta a režimu: _____
- ☐ Ak vzniknú príznaky zodpovedajúce hypofosfatémii, okamžitá kontrola fosfátu a úprava plánu: áno/nie

5) ESA alebo HIF-PHI

- ☐ Korektibilné príčiny vyriešené, najmä deficit železa: áno/nie
- ☐ Zdieľané rozhodovanie s pacientom: áno/nie
- ☐ Zohľadnené riziká a benefit vrátane transfúzií: áno/nie
- ☐ Iniciácia ESA v CKD bez dialýzy podľa symptómov, trendu Hb a rizík, nielen podľa čísla: _____
- ☐ Pri udržiavaní držať Hb **pod hornou hranicou ~11,5 g/dl**: _____

6) Monitoring

- ☐ Kontrola **Hb, ferritín, TSAT** každé **3 mesiace** alebo skôr pri zmene stavu: áno/nie
- ☐ Návrh ďalšej kontroly: [DD.MM.RRRR]
- ☐ Ak perorálne železo nefunguje alebo je netolerované do 1 až 3 mesiacov, prehodnotiť IV: áno/nie

7) Dokumentácia pre audit

- ☐ Čo bolo vyšetrené a aké hodnoty: _____
- ☐ Prečo bola zvolená cesta železa a aké prahy/argumenty: _____
- ☐ Prečo ESA/HIF-PHI áno/nie: _____

Zdroj: *KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary on the Management of Anemia in CKD.* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anemia-ckd-dialyza-ambulancia-checklist · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.